COMUNICACIÓN CLÍNICA

Alta segura y seguimiento

Cómo explicar cuidados, señales de alerta y contacto

El alta no termina al entregar un papel. El tutor necesita instrucciones escritas y verbales, saber qué vigilar y contar con una ruta clara para pedir ayuda. El plan debe ser específico del caso.

SECUENCIA DE TRABAJO

01 Resumir lo ocurrido

Indica procedimiento o motivo de ingreso, hallazgos relevantes y qué queda pendiente. Evita abreviaturas que el tutor no conozca.

02 Explicar el plan en casa

El profesional completa medicación, alimentación, actividad, protección de heridas y cuidados específicos sin depender de una plantilla genérica.

03 Delimitar alertas

Especifica qué cambios ameritan llamada, revisión el mismo día o urgencias; incluye teléfono y horario real.

04 Verificar comprensión

Pide al tutor que explique cómo seguirá el plan y resuelve barreras de administración, transporte o costo.

05 Programar contacto

Fija revisión, resultados pendientes y responsable de llamar. Documenta entrega y dudas resueltas.

COMUNICACIÓN CLÍNICA

Alta segura y seguimiento

Cómo explicar cuidados, señales de alerta y contacto

MATRIZ DE DOCUMENTACIÓN

Úsala como guía de registro. Completa los datos en la historia clínica oficial del centro.

PACIENTE Y ALTA

Identificación, fecha, diagnóstico o procedimiento y responsable.

EVIDENCIA EN EXPEDIENTE Resumen comprensible del estado al egreso.

PLAN EN CASA

Indicaciones individualizadas firmadas por el tratante.

EVIDENCIA EN EXPEDIENTE Horarios escritos y demostración si hace falta.

ALERTAS

Señales concretas según caso y nivel de urgencia.

EVIDENCIA EN EXPEDIENTE Teléfono, horario y centro alternativo.

SEGUIMIENTO

Fecha de control, pruebas pendientes y quién avisará.

EVIDENCIA EN EXPEDIENTE Constancia de entrega y comprensión del tutor.

La matriz orienta el trabajo; el registro formal corresponde al expediente clínico del centro.

COMUNICACIÓN CLÍNICA

Alta segura y seguimiento

Cómo explicar cuidados, señales de alerta y contacto

PUNTOS CLAVE PARA LLEVAR A LA PRÁCTICA

1. El diagnóstico o procedimiento está en lenguaje claro.
2. El tratante validó todas las indicaciones.
3. No quedaron dosis o tiempos sin especificar.
4. Se explicaron cuidados y limitaciones de actividad.
5. Las alertas son específicas para este paciente.
6. Hay contacto real dentro y fuera de horario.
7. El tutor explicó el plan con sus palabras.
8. Quedó fecha y responsable del seguimiento.

FRASE O CRITERIO PARA EL EQUIPO

Usa esta guía para conversar sobre el alta. La medicación y los criterios de urgencia requieren validación del veterinario responsable.

FUENTE PRIMARIA

AAHA, 2020 Anesthesia and Monitoring Guidelines, fase de retorno a casa.
https://www.aaha.org/resources/2020-aaha-anesthesia-and-monitoring-guidelines-for-dogs-and-cats/phase-3-return-home/